

1.6.7. Onasemnogene abeparvovec (如 Zolgensma suspension for Intravenous Infusion): (112/8/1、112/10/1、113/4/1)

1. 限用於治療年齡6個月以下，經標準檢測方法 MLPA(Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification)或 NGS(Next Generation Sequencing)檢測基因確診，及 SMN2基因檢驗報告，且經衛生福利部國民健康署認定之脊髓性肌肉萎縮症(Spinal muscular atrophy, SMA)病人，但不適用於已使用呼吸器每天12小時以上，且連續30天以上者。
2. 需檢附下列資料，經2位以上專家之專家小組特殊專案審查核准後使用：

(1)經衛生福利部國民健康署認定 SMA 罕見疾病個案之臨床症狀影片：

I. 經新生兒篩檢(含產前診斷)，SMN2基因拷貝數 ≤ 2 ，內容需至少出現1項肌肉相關異常：

- i. 新生兒姿態異常。
- ii. 新生兒哭聲弱。
- iii. 新生兒肌張力低下。

II. 非經新生兒篩檢(含產前診斷)，SMN2基因拷貝數 ≤ 3 ，內容需包含下列各項：

- i. 全身性低張力及對稱性近側端為主的肌無力。
- ii. 深部肌腱反射減低或消失，如：膝反射、踝反射、二頭肌反射。

(2)病歷摘要。

(3)標準運動功能評估(CHOP INTEND、HINE Section 2、WHO motor milestones)之影片，倘上述評估項目任一項已達滿分，應繼續評估下列任一項目

- I. BAYLEY-III(gross motor skills)。
- II. 若以 HFMSE 評估須滿兩歲。
- III. 若以 RULM 評估須滿兩歲六個月。

(4)「全民健康保險保險對象使用 onasemnogene abeparvovec 基因療法製劑協議書」(附表三十七)(113/4/1)。

3. 排除條件：

- (1)需使用侵入性呼吸器或血氧飽和度 $<95\%$ 。
- (2)經酵素免疫分析法檢測，血液中 Anti-AAV9抗體效價 $>1:50$ 。
- (3)已使用過 Nusinersen 或 Risdiplam。

4. 療效評估時機、判定及執行者：

(1)標準運動功能評估時機：

- I. Onasemnogene abeparvovec 治療前。
- II. Onasemnogene abeparvovec 治療後，每4個月評估1次，倘 CHOP INTEND 或 HINE Section 2或 WHO motor milestones 任一項評估已達滿分，應繼續評估下列任一項目：

i. BAYLEY-III(gross motor skills)。

ii. 若以 HFMSE 評估須滿兩歲。

iii. 若以 RULM 評估須滿兩歲六個月。

(2)標準運動功能評估判定者：

I. 需由提供 Onasemnogene abeparvovec 治療之兒科專科醫師選擇下列各項適合療效評估工具，並判定評估結果：

i. CHOP INTEND。

ii. HINE Section 2。

iii. WHO motor milestones。

II. 倘上述任一項目評估已達滿分，則以下列任一項目繼續評估：

i. BAYLEY-III(gross motor skills)。

ii. 若以 HFMSE 評估須滿兩歲。

iii. 若以 RULM 評估須滿兩歲六個月。

(3)標準運動功能評估執行者：需由受過訓練之兒科專科醫師或物理治療師執行。

5. 使用本類藥品治療每年應檢附年度追蹤報告書，包括每4個月評估1次之標準運動功能、發展里程碑之錄影影片及病歷資料，並評估追蹤療效（下列評估需在 SMA 病人非急性住院期間執行，且病人需遵從標準支持治療），且每年均需符合下列各條件(112/10/1)：

(1)存活。

(2)在非急性住院期間，未使用呼吸器，或有使用呼吸器但未達每天12小時，且連續30天。（需於年度報告書中，提交使用呼吸器之相關臨床醫療紀錄，以佐證上述治療情形）(112/10/1)

(3)用藥後追蹤 CHOP INTEND、HINE Section 2、WHO motor milestones 評估分數至少有一次不低於起始治療前該項標準運動功能第1次評估分數。（註：如上述評估項目之評估分數每次均低於起始治療前該項標準運動功能之第1次評估分數，則表示未達療效。）(112/10/1)

(4)CHOP INTEND 或 HINE Section 或 WHO motor milestones 任一評估分數已達滿分，應繼續評估下列任一項目，且評估分數至少有一次不低於開始該項標準運動功能第1次評估分數。（註：若評估項目之評估分數每次均低於開始該項標準運動功能之第1次評估分數，則表示未達療效。）(112/10/1)

i. BAYLEY-III(gross motor skills)。

ii. 若以 HFMSE 評估須滿兩歲。

iii. 若以 RULM 評估須滿兩歲六個月。

(5)用藥後追蹤發展里程碑(獨自坐立≥30秒或獨自站立≥10秒或獨自行走≥5步)，不得有退化。（註：當年度2次以上評估均失去已達成之發

展里程碑，則表示退化。) (112/10/1)

6. 使用本藥品需完成個案系統登錄，亦需登錄每次評估療效或停止評估後，於此系統登錄結案。
7. Onasemnogene abeparvovec 或 nusinersen 或 risdiplam 限擇一使用，且不得互換。
8. 使用本藥品病人需簽署「全民健康保險保險對象使用 onasemnogene abeparvovec 基因療法製劑協議書」。(附表三十七) (112/10/1、113/4/1)。

附表三十七-全民健康保險保險對象使用 onasemnogene abeparvovec 基因療法製劑協議書

衛生福利部中央健康保險署（以下簡稱甲方）為辦理全民健康保險（以下稱本保險）業務與保險對象____（姓名）____（以下簡稱乙方）就含 onasemnogene abeparvovec 基因療法製劑（商品名稱為「Zolgensma」，以下簡稱本協議藥品）之給付事宜簽訂本協議書，內容如下：

壹、 甲方同意乙方申請使用 onasemnogene abeparvovec 基因療法製劑，於符合本協議藥品給付規定並經特殊專案審查核准時，委由本保險特約醫事服務機構（機構名稱）施打本協議藥品及相關作業事宜。

貳、 甲方授權（特約醫事服務機構名稱）（○○○醫師）代表告知乙方下列事項與應負擔義務，並經乙方同意如下：

- 一、 乙方使用 onasemnogene abeparvovec 基因療法製劑，需依照本協議藥品給付規定內容（包括且不限於施打劑量、次數、方式、地點），並於使用該基因療法製劑之日起每4個月主動回到施打該藥品之醫院進行療效評估，且至少持續10年。
- 二、 乙方應配合並同意甲方蒐集運用相關醫療資訊，作為後續醫療給付核定依據及效益評估之參考。
- 三、 乙方或其法定代理人任一人，如發生聯絡方式(地址、電話…)變更、遷移他地、失蹤或其他情事，致無法按時回院進行療效評估時，乙方及其法定代理人應於事由發生之日起30天以書面通知甲方及施打藥品之特約醫事服務機構，並提供變更後可確實連絡之方式與地址，必要時應檢附證明資料。
- 四、 本協議書不因乙方之法定代理人變更或喪失資格而失其效力，但乙方之法定代理人變更時，原法定代理人應主動告知繼任者本協議書之存在與內容。
- 五、 本協議書簽訂後，如發生法規變更或政策調整或廠商不再提供本協議

藥品，甲方得減、免提供乙方本協議藥品，但應依全民健康保險相關法規採取其他方法協助乙方之治療。

六、 乙方及其法定代理人有未遵守本條第一項至第四項任一規定時，經甲方或施打藥品之特約醫事服務機構通知限期改善而未改善，甲方不予給付後續治療脊髓肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy, 簡稱 SMA) 相關用藥及費用。乙方不得異議，亦不得要求任何補償。

參、 本協議書正本二份，副本一份。正本由甲方、乙雙方各執一份存照，副本一份由甲方存照。

肆、 本協議書之成立、解釋及執行應以中華民國法律為準據法，任何因本協議書有關之爭議，應以臺北高等行政法院為第一審管轄法院。

伍、 本協議書未盡事宜，概以全民健康保險法暨相關法規、行政程序法第三章行政契約及民法等辦理或補充之。

甲方：衛生福利部中央健康保險署

代表人：○

地址：臺北市大安區信義路3段140號

電話：

乙方：

出生日期： 年 月 日

身分證號：

地址：

法定代理人（未成年人需經法定代理人之同意）：

與乙方之關係：

法定代理人之身分證號：

地址：

電話：

中華民國 年 月 日